

41. PRATICA 2 LA STRUTTURA COLICA

DURATA : 03:23

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Presentazione delle tecniche di rivitalizzazione corporea post-cesareo, incentrate sul colon e sul peritoneo. Esame palpatorio dell'addome che include la risposta tissutale e termica per ripristinare l'omogeneità fasciale. Analisi del fulcro terminale, dei rilasci tissutali e dell'adattamento dinamico richiesto dopo interventi pelvici (es. isterectomia). Metodologia clinica per favorire una reintegrazione tissutale armoniosa.

PRATICA 2: LA STRUTTURA COLICA

Un **taglio cesareo** seziona il corpo tra l'alto e il basso, richiedendo una **ridinamizzazione**. L'utero rappresenta una concentrazione di **peritoneo parietale posteriore**. Durante lo sviluppo nel peritoneo, esiste una concentrazione e una potenza che si ricentrano, formando un **fulcro terminale**. Questo fulcro è sia embrionale che finale, ed è cruciale riportarli alla consapevolezza.

Durante la palpazione, è essenziale prendere tutta la pancia tra le mani, mantenendo le mani ben rilassate. Una respirazione troppo alta può indicare una richiesta di **discrezione**. Il **calore** percepito è uno scambio tra il praticante e il paziente, dove il tessuto inizia a dare informazioni. Se il tessuto si mette in difesa, la zona inferiore inizia a rilassarsi, mentre la parte superiore manca ancora di omogeneità. L'obiettivo è ritrovare uno stato omogeneo.

Quando il calore aumenta, tutte le linee di forza sembrano orientarsi verso la zona uterina, come se il tessuto reintegrasse il suo **nido**. Questo aiuta il paziente a tornare nella sua **casa interiore**, simile a qualcuno attaccato alla sua terra. A questo punto, il praticante può allargare il suo contatto all'intero corpo, avviando un **processo terapeutico**. L'integrazione verso la zona uterina si rafforza, e una maggiore omogeneità si crea tra le mani.

Nel caso di un'**isterectomia**, la dinamica corporea cambia, e il paziente può sviluppare una **gobba di bisonte**. Ciò richiede un riequilibrio in diverse zone. Il lavoro si concentra su punti tissutali, permettendo un rilascio dei tessuti e uno sviluppo sincronizzato. I punti di appoggio sono essenziali, in particolare per obbligare il **diaframma** a lavorare diversamente, cercando altri spazi e aperture.

Il praticante può quindi affrontare zone specifiche come l'epatica e il sigmoideo, permettendo un rilassamento completo.

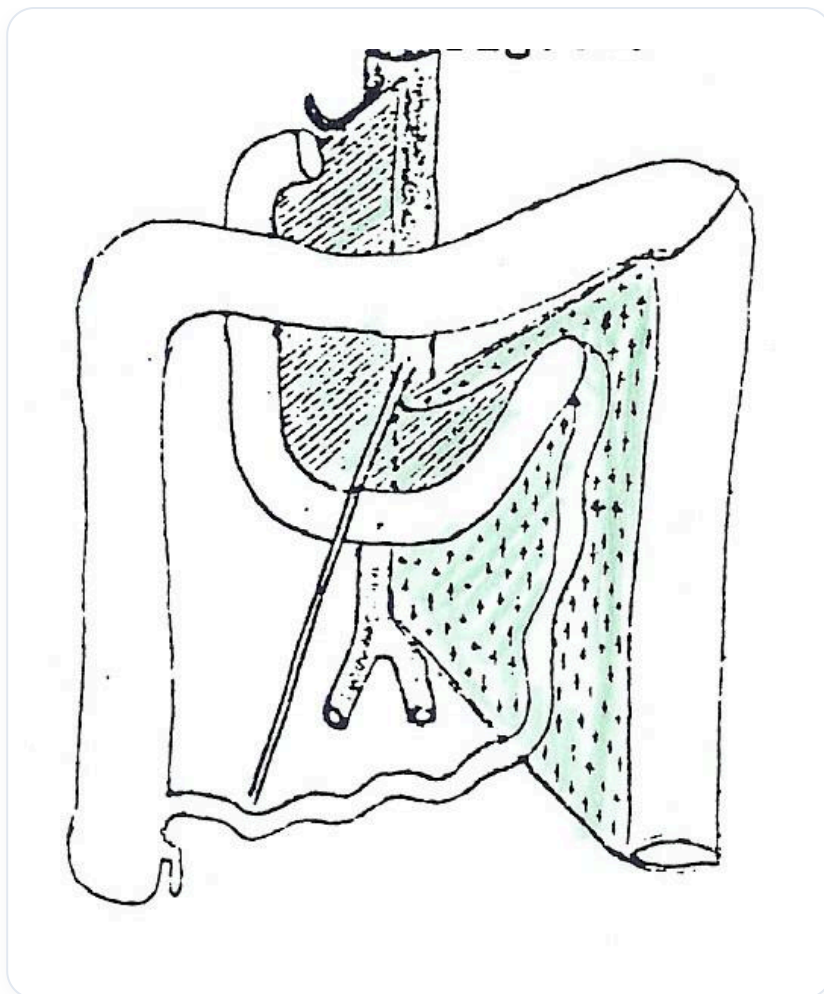


FIG. — *Anatomia del colon*